

Gérer le relais (switch) entre antipsychotiques

💊 Lors des traitements antipsychotiques au long cours, il est fréquent de changer de molécule, que ce soit pour augmenter l'efficacité du traitement, ou pour diminuer les effets indésirables. Ce relais (switch) entre deux antipsychotiques se déroule souvent sans problème, mais demande quelques précautions pour minimiser les risques :

- ⚠️ de rechute si le 1^{er} antipsychotique est arrêté trop rapidement alors que le 2nd n'est pas encore à dose efficace
- ⚠️ de sevrage si le 1^{er} et le 2nd antipsychotique n'ont pas le même profil pharmacologique
- ⚠️ d'événements indésirables liés aux effets cumulatifs des 2 antipsychotiques

💊 Les deux pièges à connaître sont

- ⚠️ d'attribuer une rechute à l'absence d'efficacité du nouveau antipsychotique, alors que celui-ci n'est pas encore à dose efficace
- ⚠️ d'attribuer systématiquement la survenue d'événements indésirables au nouveau antipsychotique, alors qu'ils peuvent être liés à l'arrêt trop rapide du précédent

💊 En règle générale, la stratégie recommandée est un relais graduel sur une période de chevauchement d'une à deux semaines, avec une ↘ progressive des doses du 1^{er} antipsychotique et une ↗ progressive des doses du 2nd. Il existe plusieurs sites (pas toujours concordants) qui guident l'adaptation des doses pour chaque couple de molécules par ex

⚠️ <https://australianprescriber.tg.org.au/articles/antipsychotic-switching-tool.html>

⚠️ <https://www.psychiatrienet.nl/switchtabel/show?id=SwitchAntipsychotics>

⚠️ Des précautions particulières doivent être prises avec deux antipsychotiques

- ⚠️ l'aripiprazole du fait de son effet agoniste dopaminergique partiel
- ⚠️ la clozapine du fait de sa forte activité anticholinergique

🎯 Pour l'aripiprazole, la règle de base est que l'arrêt aussi bien que l'introduction doivent être rapides

- ⚠️ relais aripiprazole vers autre antipsychotique : maintenir la dose d'aripiprazole tant que le 2nd antipsychotique n'est pas à dose efficace, puis arrêter directement l'aripiprazole
- ⚠️ relais autre antipsychotique vers aripiprazole : débiter directement l'aripiprazole à 10-15 mg (selon dose cible), maintenir le 1^{er} antipsychotique à la même dose une à deux semaines puis le diminuer

🎯 La clozapine doit toujours être ↘ très lentement hors situations d'urgence (neutropénie sévère, myocardite, etc.) :

- ⚠️ le sevrage anticholinergique brutal peut entraîner un syndrome catatonique, sauf si la nouvelle molécule a aussi cet effet (par ex olanzapine)
- ⚠️ l'arrêt se fait sur plusieurs semaines, avec des paliers de 25 mg tous les deux à trois jours maximum, voire encore plus lentement si besoin (3-6 mois)
- ⚠️ les doses du nouveau antipsychotique sont ↗ progressivement (sauf aripiprazole cf point précédent)
- ⚠️ cela permet aussi d'évaluer l'efficacité du nouveau antipsychotique, notamment en cas de résistance antérieure

⚠️ Il s'agit de règles générales, à adapter à chaque personne en fonction des autres traitements et pathologies. L'essentiel est de connaître les profils pharmacologiques des différents antipsychotiques.

Références

<https://doi.org/10.1177/0269881120922964>

<https://doi.org/10.1007/s00213-019-05352-7>

Relais (switch) entre antipsychotiques



règle générale : période de chevauchement

minimiser les risques

- ◇ arrêt trop rapide : sevrage
- ◇ augmentation trop lente : rechute



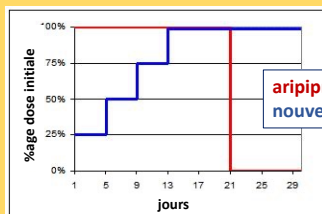
relais sur 2-3 semaines

- ◇ ↓ progressive 1^{er} antipsychotique
- ◇ ↑ progressive 2nd antipsychotique

aripiprazole

effet agoniste dopaminergique partiel

- ◇ introduction et arrêt rapides

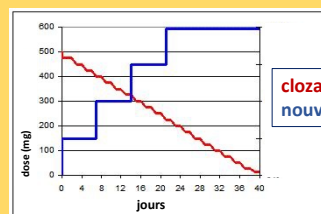


aripiprazole
nouveau AP

clozapine

risque de sevrage anticholinergique

- ◇ arrêt très lent sur plusieurs semaines/mois



clozapine
nouveau AP